VIDAPLUS — SGHSS

Etapa 2 — Levantamento e especificação de requisitos

Acadêmico: José Everaldo de Barros | RU: 4972245

Projeto Multidisciplinar — Engenharia de Software | Versão 1.0 — 19/10/2026

1. Contexto e objetivo

O Sistema de Gestão Hospitalar e de Serviços de Saúde (SGHSS) é proposto para a instituição fictícia VidaPlus, que reúne hospitais, clínicas, laboratórios e atendimento domiciliar. Este documento transforma o estudo de caso em requisitos verificáveis para orientar a modelagem, a implementação de um produto mínimo viável (MVP) e os testes.

2. Perfis e limites do MVP

Paciente: consulta seus agendamentos e solicita ou cancela consultas. Profissional: consulta a agenda e registra atendimentos autorizados. Administrador: gerencia pacientes, profissionais, unidades e agendas. O MVP prioriza cadastro, autenticação, agendamento e registro simples de atendimento; telemedicina, receitas digitais, internações, estoque e relatórios financeiros ficam documentados como expansão, sem alegar que foram implementados.

3. Requisitos funcionais

ID	Descrição / prioridade
RF01	Autenticar usuários com credenciais e identificar seu perfil de acesso. [MVP]
RF02	Cadastrar, consultar e atualizar pacientes, validando campos obrigatórios. [MVP]
RF03	Cadastrar, consultar e atualizar profissionais e especialidades. [MVP]
RF04	Cadastrar unidades de atendimento e associar profissionais às unidades. [MVP]
RF05	Cadastrar horários disponíveis dos profissionais por unidade. [MVP]
RF06	Agendar consultas vinculando paciente, profissional, unidade, data e horário. [MVP]
RF07	Impedir agendamento duplicado para o mesmo profissional, data e horário. [MVP]
RF08	Listar consultas segundo o perfil; permitir cancelamento com registro do estado. [MVP]
RF09	Registrar resumo de atendimento e histórico clínico com acesso restrito. [MVP simplificado]
RF10	Emitir notificações de confirmação ou cancelamento de consultas. [Expansão]
RF11	Disponibilizar teleconsulta com comunicação segura. [Expansão]
RF12	Permitir prescrição digital conforme exigências legais aplicáveis. [Expansão]
RF13	Gerenciar leitos e fluxo de internações. [Expansão]

ID	Descrição / prioridade
RF14	Emitir relatórios administrativos e financeiros. [Expansão]
RF15	Gerenciar exames, laboratórios e solicitações. [Expansão]
RF16	Registrar eventos de auditoria para ações sensíveis. [MVP]

4. Requisitos não funcionais

ID	Descrição / critério
RNF01	Acesso por perfis (paciente, profissional e administrador), com autorização verificada no servidor.
RNF02	Senhas armazenadas com algoritmo apropriado de hash e sal; nunca em texto puro.
RNF03	Dados sensíveis protegidos em trânsito por HTTPS em produção; segredos fora do código-fonte.
RNF04	Tratamento de dados pessoais compatível com a LGPD: finalidade, minimização e controle de acesso.
RNF05	Disponibilidade-alvo de pelo menos 99,5% em produção; meta não demonstrada pelo protótipo local.
RNF06	Interface responsiva e acessível, considerando WCAG e navegação por teclado.
RNF07	Consultas críticas com meta inicial de resposta de até 2 segundos sob carga definida em teste.
RNF08	Estrutura que permita adicionar múltiplas unidades sem duplicar a lógica de negócio.
RNF09	Backups periódicos e procedimento de restauração testável para implantação futura.
RNF10	Logs sem senhas, tokens ou dados clínicos completos; trilha de auditoria de alterações relevantes.

5. Regras de negócio

Regra	Definição
RN01	Uma consulta ocupa um único horário de um profissional em uma unidade.
RN02	O agendamento exige paciente e profissional ativos e horário disponível.
RN03	Somente profissionais autorizados podem registrar informações clínicas de atendimentos sob sua responsabilidade.
RN04	O paciente só visualiza suas próprias consultas e informações permitidas.
RN05	Cancelamentos preservam o histórico do agendamento e não excluem registros clínicos.
RN06	Datas e horários devem ser consistentes com o fuso definido para a unidade.

6. Critérios de aceitação do MVP

Teste	Resultado esperado
CA01	Login válido redireciona ao painel adequado; login inválido não concede acesso.
CA02	Cadastro de paciente rejeita campos obrigatórios ausentes.
CA03	Administrador consegue vincular profissional a uma unidade.
CA04	Agendamento válido aparece nas agendas do paciente e do profissional.
CA05	Tentativa de reservar o mesmo horário retorna erro de conflito, sem duplicação.
CA06	Paciente não consegue visualizar consulta pertencente a outro paciente.
CA07	Cancelamento altera o status, mantendo o registro para auditoria.
CA08	Registro clínico não fica acessível a usuários sem autorização.

7. Rastreabilidade inicial

RF01 → CA01; RF02 → CA02; RF03/RF04 → CA03; RF05/RF06 → CA04; RF07 → CA05; RF08 → CA06/CA07; RF09 → CA08. Os requisitos de expansão serão avaliados em documentação, não nos testes funcionais do MVP.

8. Premissas, riscos e próximos passos

Premissas: ambiente de demonstração e dados inteiramente fictícios; a escolha de tecnologia e a rota acadêmica específica ainda precisam de confirmação. Riscos: acesso indevido a informações clínicas, conflitos de agenda e ampliação excessiva do escopo. Próxima etapa: elaborar casos de uso, modelo de dados e arquitetura com base nos requisitos acima.

9. Referência

UNINTER. Roteiro de Atividade Prática de Projeto Multidisciplinar: estudo de caso SGHSS — VidaPlus. Material disponibilizado pelo estudante (arquivo Atividade Prática.pdf).